出现纵隔移位→胸腔积液量大→胸膜脏、壁两层分开→无胸膜摩擦音

3.健侧典型体征——**纵隔（气管、心脏）可向健侧移位**（纵隔移位和胸膜摩擦音不共存）

《诊断学》：纵隔（气管、心脏）ttsx：

①向健侧移位：胸腔积液、气胸等 推向健侧

②向患侧移位：慢纤空、慢性肺脓肿、慢性脓胸、肺不张、明显胸膜粘连增厚等 收缩牵拉

③多不移位：上述疾病较轻时、COPD、支气管哮喘、大叶性肺炎实变、肺泡性肺水肿等

病变呈双侧→多不移位　肺泡内纤维素渗出　肺泡内渗出水

（三）胸腔积液的辅助检查

1.影像学检查

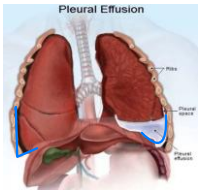
（1）**X 线** 又看肺又看胸膜腔

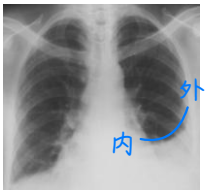
①诊断胸腔积液的**首选**

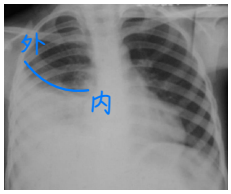
②极小量积液（300ml）仅见**肋膈角变钝**；随积液量增多可见**外高内低弧形致密影**；甚至可见患侧胸部致密影

③分度：积液最高处在第 4 前肋以下为少量、第 4 至第 2 前肋之间为中量、第 2 前肋以上为大量

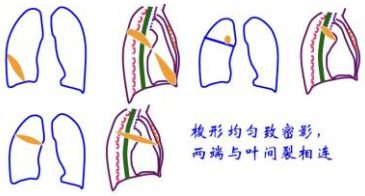
④包裹性积液呈 D 字型，不随 ttsx 体位变动



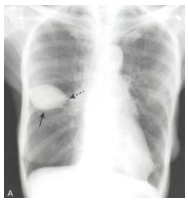












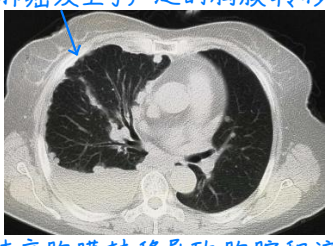
容易受气体干扰(看肺效果不如X线)

（2）超声

①诊断胸腔积液灵敏度高液体没有回声

②**定位准确**，可**引导胸腔穿刺**

肺癌发生了广泛的胸膜转移





肺癌胸膜转移导致胸腔积液　图 2-13-3　X 线胸片示左侧胸腔积液

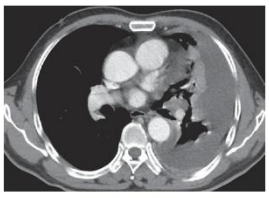


图 2-13-4　胸部 CT 示左侧胸腔积液

（3）CT

可提示积液性质、有助于病因诊断

不能完全确定积液性质,要完全确定需要做胸穿

2.胸腔穿刺：①能改善症状；②**明确胸腔积液性质（病因诊断）的金标准**

检查小结：

（1）诊断胸腔积液：①X 线首选；②B 超对液体最敏感、且定位准确（引导胸腔穿刺）；③CT 有病因提示作用

（2）明确胸腔积液的性质（病因诊断）

①胸腔穿刺：金标准

②**胸腔镜**：高度怀疑恶性胸水（如肺癌）金标准